Evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje oral

Unidad 3. Clasificación, descripción y etiología de las alteraciones del habla y la voz (II)

UNIDAD 3

Unidad 3. Clasificación, descripción y etiología de las alteraciones del habla y la voz (II)

ÍNDICE

1. Introducción....2

2. Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral 2

2.1. Alteraciones del habla y la voz secundarias....2

2.1.1. Introducción.... 2

2.1.2. Disartria 4

2.1.2.1. Conceptualización, características y desarrollo de la alteración 4

2.1.2.2. Taxonomía diferencial 4

2.1.2.3. Evaluación.... 6

2.1.2.4. Intervención.... 7

2.1.3. Disglosia 9

2.1.3.1. Conceptualización, características y desarrollo de la alteración 9

2.1.3.2. Taxonomía diferencial 9

2.1.3.3. Evaluación.... 10

2.1.3.4. Intervención.... 11

2.1.4. Disfonía 13

2.1.4.1. Conceptualización.... 13

2.1.4.2. Taxonomía diferencial 13

2.1.4.3. El particular caso de la disfonía infantil: introducción 14

2.1.4.4. El particular caso de la disfonía infantil: evaluación e intervención 15

BIBLIOGRAFÍA....19

1. Introducción

Las alteraciones del habla y la voz son alteraciones, muchas veces coexistentes, que pueden afectar a la articulación, la fonología, la voz y/o la fluencia, aunque también pueden deberse a causas desconocidas, es decir, estar asociadas con obstáculos en la estructura o función de la boca, cara o paladar, pérdida de audición, alteraciones de las cuerdas vocales o a la frecuencia respiratoria, desequilibrio en los sonidos producidos, o incluso relacionarse con una respuesta al estrés ambiental (Coll-Florit et al., 2014).

En relación con ello, cualquier clasificación de los factores patológicos del habla y la voz, y, con ellas, del lenguaje tiene una cuota de arbitrariedad y, por eso, son numerosas las taxonomías que se han establecido a lo largo de la literatura clínica, logopédica y educativa (Cepeda, 2019).

Teniendo en cuenta lo anterior en esta unidad tiene como objetivos: (I) trabajar con la clasificación general de las alteraciones del lenguaje oral y sus implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje; (II) visualizar la panorámica de todas las alteraciones del lenguaje oral existentes para, posteriormente, hacer especial hincapié, en las alteraciones del habla y la voz y, por último, (III) conocer la evaluación e intervención de los diversos trastornos del habla y la voz para, como especialistas, poderlos aplicar, teniendo en cuenta sus implicaciones, en el ámbito de la enseñanza.

2. Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral

2.1. Alteraciones del habla y la voz secundarias

2.1.1. Introducción

Como se expuso en puntos anteriores, una de las clasificaciones más utilizadas dentro del campo de las alteraciones del lenguaje oral es la llevada a cabo por Susanibar et al. (2016), quienes las dividien en tres vertientes principales: habla y voz; fluidez y desarrollo del lenguaje (véase Figura 1).

Las **alteraciones del habla** son alteraciones, muchas veces **coexistentes**, que **pueden afectar a la articulación, la fonología, la voz y/o la fluidez**, aunque también pueden deberse a causas desconocidas (Coll-Florit et al. 2014), es decir, estar asociadas con:

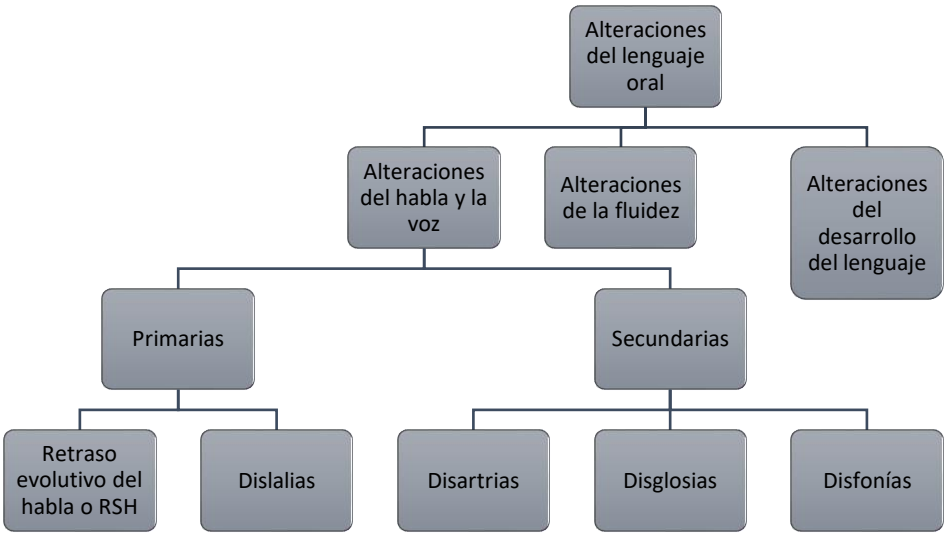
- Obstáculos en la estructura o función de la boca, cara o paladar, pérdida de audición.
- Alteraciones de las cuerdas vocales o a la frecuencia respiratoria.
- Desequilibrio en los sonidos producidos.
- Respuesta al estrés ambiental.

Las **características principales** de estas alteraciones son:

- Etiología de carácter múltiple: *afectivo, evolutivo, cultural, traumático, psicológico.*
- Habla espontánea poco inteligible.
- Errores práxicos y *feedback* auditivo deficiente.
- Si la alteración está generalizada, la articulación o el habla se verán gravemente afectados.
- Dificultad para establecer diferenciaciones auditivas precisas.
- Nivel lingüístico máximo afectado: la palabra.

Figura 1.

Clasificación de las alteraciones del lenguaje oral (Susanibar et al., 2016)



Por su parte, la voz es un sonido que se produce en la laringe, pero cuyos criterios objetivos y absolutos no existen. Sin embargo, sí se debe tener claro que para realizar dicho sonido será preciso conjugar múltiples aspectos psicofisiológicos que determinen su calidad, acústica y su ejecución (Susanibar et al. 2016).

Se considera que hay una alteración de la voz cuando **su timbre, tono, intensidad o flexibilidad difieren de los de las voces de las demás personas del mismo género, edad y grupo cultural con desarrollo típico.** Entre las **causas** de las alteraciones de la voz destacan**:**

- Bronquitis crónica, asma, vegetaciones, laringitis.
- El origen de los problemas de voz puede ser:
- Traumático (accidentes, sustos).
- Ambiental (elevación de la voz en situaciones ruidosas).
- Funcional (pólipos, nódulos en la garganta).
- Orgánico (malformaciones laríngeas).

2.1.2. Disartria

2.1.2.1. Conceptualización, características y desarrollo de la alteración

La disartria implica una alteración de la articulación de los fonemas, atribuyéndose a una lesión del sistema nervioso central y periférico que ocasiona alteración en el control en la fuerza, velocidad, rango, regularidad tono o en la precisión de los movimientos de los músculos de los órganos fonoarticulatorios. Comprendiendo, además, disfunciones motoras de la respiración, fonación, resonancia, articulación y aspectos prosódicos del habla (APA, 2022).

Dentro de esta alteración se descartan aquellas dificultades del desarrollo de la articulación, la tartamudez o aquellos basados en una alteración somática estructural psicológica. En aquellos casos en que la disartria sea muy severa, llegando a imposibilitar la articulación, se estará hablando de una anartria (Peña, 1995).

Entre sus características diferenciales se encuentran:

- Pérdida de la capacidad de articular las palabras con normalidad.
- El habla es entrecortada, jadeante, irregular, imprecisa o monótona, pero la persona afectada puede comprender el lenguaje y usarlo correctamente.
- Baja habilidad psicomotora y desorientación tempo espacial.

2.1.2.2. Taxonomía diferencial

Las disartrias son una alteración que afecta a la motricidad causado por diferentes factores etiológicos: vasculares, traumáticos, infecciosos, neoplásicos o degenerativos que afectan al sistema nervioso central y periférico (véase Tabla 1). Pudiendo ser de causa congénita o adquirida, y presentando diferentes grados de intensidad. Estos factores son los que determinarán su evolución junto a las características del sujeto y una posible recuperación, así como a influyen en la intervención logopédica que se pueda llevar a cabo (Melle, 2012)

Tabla 1.

Clasificación de las disartrias (Hernández, 2007)

Tipología	Caracterización
Disartria espástica	El origen es una alteración en la neurona motora superior, la cual es un conjunto de neuronas motoras situadas en el córtex cerebral conectadas en la médula espinal, presentando lesiones en los tractos piramidales relacionados con el control motor fino de los músculos de la cara y del cuello, por lo que la mímica se ve afectada.
Disartria flácida	Es producida por una alteración en la neurona motora inferior afectando al núcleo motor, a los axones y a la placa neuromuscular, provocando flacidez y parálisis con disminución de los reflejos musculares y afecta a los movimientos voluntarios, automáticos y

	reflejos. Los nervios que se encuentran afectados en la disartria flácida y las consecuencias de esta son: nervio trigémino, nervio facial, nervio glosofaríngeo, nervio vago y nervio hipogloso.
Disartria hipocinética	Se produce por una lesión en el sistema extrapiramidal, el cual es el encargado de regular el tono muscular en reposo y en movimiento, así como los movimientos automáticos. Asociándose a una disminución en la cantidad y velocidad de los movimientos por compromiso de este sistema.
Disartria hipercinética	Causada, de forma general, por lesiones en los ganglios basales y las estructuras subcorticales implicadas en los movimientos involuntarios. Se produce por enfermedades que presentan movimientos coreicos por el tipo de lesión del Sistema Nervioso.
Disartrias mixtas	Es el tipo más complejo de disartria que existe e implica una mezcla de las características o signos de otro tipo de disartrias como son la espática, la flácida y la atáxica, empleándose entonces esta clasificación clínica cuando se da en un sujeto un conjunto de signos que no corresponden a una disartria de forma específica.
Disartria atáxica	Se produce por una lesión en el cerebelo, el cual es el encargado de regular la fuerza, la extensión, la duración y la dirección de los movimientos musculares.
Disartria bulbar	Se presenta cuando existe una alteración o lesión en el bulbo raquídeo.
Disartria pseudobulbar	Es consecuencia de una lesión bilateral localizada en las vías corticobulbares que unen la corteza cerebral, que envía los estímulos voluntarios, con los centros del bulbo raquídeo. Se puede deber a infartos lacunares o enfermedades como ELA.
Disartria cerebelosa	La lesión se localiza en el cerebelo, pudiendo provocar diferentes grados de afectación, pero se suelen encontrar afectados por las funciones del cerebro, el habla, el control muscular, la voz, el equilibrio, etc. Si solo se produce daño en la corteza del cerebelo, no se provocará ninguna alteración ni consecuencia importante, ya que para que exista una disartria cerebelosa grave los núcleos del cerebelo más profundos deben verse muy comprometidos, y así causar una disfunción grande.
Disartria subcortical	Aparece al lesionarse la vía extrapiramidal y los ganglios basales integrados por el cuerpo estriado, globos pallidus, sustancia negra, claustro y cuerpo amigdalino.
Disartria central	Se produce por una lesión en el tracto corticoespinal. Surge en enfermedades como ELA o miastenia grave.
Disartria de conducción	Se produce por una alteración en la conducción nerviosa del sistema nervioso, provocando alteración en las funciones que controlan el habla y los movimientos musculares.
Disartria periférica	Se produce debido a una afectación del sistema nervioso periférico que provoca reflejos en patrones disfuncionales del movimiento muscular. Se asemeja y relaciona con la flácida debido a las características en la lesión que se produce.

Según Hernández (2007), la clasificación clínica que se lleva a cabo en este tipo de alteración hace referencia a la afectación del sistema nervioso que se produce y a las características que provocan en la persona, existiendo los siguientes tipos principales de disartrias (aunque también se trabajarán los secundarios): flácida, espástica, hipocinética, hipercinética, y anartria, esta última es entendida como la forma más grave de disartria, por lo que algunos autores o profesionales no la incluyen como un tipo de disartria, sino como una alteración aparte de la comunicación.

2.1.2.3. Evaluación

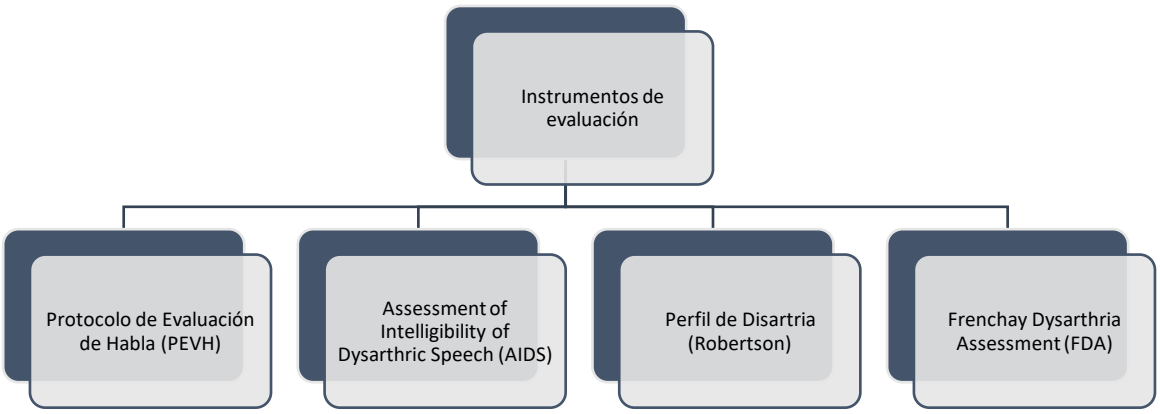
Entre los pasos a realizar en la evaluación de las disartrias destacan, en primer lugar, la historia clínica, este momento de la evaluación consiste en registrar todos los datos relacionados con la persona, con el inicio de la alteración y todos los datos relacionados acerca del curso de la dificultad, desde el inicio hasta ese momento, este campo es de corte clínico (Hernández, 2007).

En segundo lugar, destaca la entrevista inicial, es decir, el momento en el que se queda con el sujeto o con la familia, en el caso de un niño, para recopilar información acerca del desarrollo, la conciencia que se tiene de las dificultades y el conocimiento de la propia alteración (Ortiz, 2014). Además, se preguntará a cerca de las consecuencias de la alteración que presenta en el momento de evaluación y que haya sufrido en el pasado en relación con esto. En este sentido, será importante recopilar información acerca de las conductas compensatorias que hubieran podido aparecer debido al padecimiento de este alteración comunicativa (Ortiz, 2014).

En tercer lugar, se encuentra la evaluación mediante pruebas o test estandarizados, siendo estos el punto de partida para el inicio de la posterior intervención por parte del especialista en audición y lenguaje (véase Figura 2). En este momento, se llevan a cabo el desarrollo evaluaciones complementarias que permiten conocer las características del niño y el funcionamiento sensorial, neurológico y cognitivo.

Figura 2.

Nómina de instrumentos de evaluación estandarizada en las disartrias (Ortiz, 2014)



Finalmente, a través de los procesos anteriores, se procederá a valorar y comparar los resultados obtenidos por todos los profesionales valoradores, estableciendo una conclusión acerca de la etiqueta que engloba las dificultades que presenta el sujeto (Melle, 2012).

Dependiendo del caso con el que se encuentre, se podrá acudir a otros entornos para recibir información, como pueden ser lugares de actividades extraescolares a los que acuda el sujeto, pediatra, otros profesionales sanitarios o de otros ámbitos (Cepeda, 2019). Estos entornos darán información de cómo se desenvuelve el sujeto, cómo es su carácter y qué dificultades observan ellos o qué aspectos creen que pueden afectar al niño y su desarrollo para que se puedan abordar.

2.1.2.4. Intervención

La intervención en disartria no puede ser abordada exclusivamente desde el punto de vista lingüístico, ya que las alteraciones articulatorias son un trastorno específico derivado de una alteración motriz, pero no el único, de ahí la necesidad de un abordaje cooperativo en el que participarán simultánea o alternativamente los profesionales que han intervenido en su evaluación.

A la hora de llevar a cabo la intervención sobre la alteración, esta va a tener que estar acompañada de una serie de estrategias encaminadas a dirigir una intervención funcional (Hernández, 2007). Teniendo en cuenta lo anterior, algunas de las estrategias que se pueden o se deben manejar para la intervención en los casos de disartria según Hernández (2007); Melle (2012) y Ortiz (2014), son:

1. Evitar obligar al sujeto a llevar a cabo una conversación sobre todo cuando esté cansado, como puede ser en el final de una sesión. Debido a que después de realizar las actividades y/o ejercicios el sujeto va a experimentar un detrimento en su actuación y en sus capacidades.
2. Realizar un habla lenta al comunicarse con el sujeto afectado, sin prisas y utilizando pausas necesarias y adecuadas, con el objetivo de ayudar a la comprensión del mensaje.
3. Crear en la sala un entorno tranquilo, relajado y silencioso para llevar a cabo la intervención y que esta sea lo más funcional posible.
4. Cuando se produzcan errores de los que el sujeto sea consciente o presente incapacidad para llevar a cabo algún ejercicio o actividad, se debe animarlo y dejarle claro que a los inicios es complejo llevarlo a cabo, debido a las alteraciones provocadas por la alteración.

5. Facilitar la comunicación en todos sus entornos a través de estrategias y consejos, valorando si es necesario el uso de algún sistema que ayude a incrementar la interacción comunicativa.
6. Basarse en situaciones reales y comunes en la vida diaria para llevar a cabo ejercicios y actividades de práctica comunicativa que pueda emplear en su día a día.
7. Crear un clima y una relación de confianza, al igual que con la familia, con el objetivo de apoyar a todos en el proceso y aportándoles ayuda en lo que puedan requerir.
8. Estimular la afectividad de forma adecuada, intentando hacer entender a la familia que se debe procurar no sobreproteger. Teniendo que exigir en relación con la implicación y actuación en la intervención, pero sin ser exagerados en los requerimientos.
9. Emplear estrategias comunicativas adecuadas y personalizadas al caso y al entorno, según lo que sea más beneficioso para él.

En relación con la tipología de actividades que se pueden llevar a cabo dentro del área de audición y lenguaje, estas, tal y como apunta Melle (2012), se clasifican en tres grandes bloques: iniciación a la intervención, articulatorias y propias del lenguaje oral (véase Tabla 2).

Tabla 2.

Tipología de actividades para la intervención en disartria (Melle, 2012)

Tipología de actividades	Descripción
Iniciación a la intervención	• **Trabajo de soporte respiratorio para el habla:** control de la espiración durante la fonación (por ejemplo, contar en voz alta lo más lejos posible con una sola respiración). • **Ejercicios de fonación prolongada:** mantener la emisión de una vocal el mayor tiempo posible y con la máxima intensidad. • **Ejercicios de esfuerzo articulatorio máximo:** producción de sílabas y palabras con exageración consciente de los movimientos articulatorios, para mejorar la precisión del habla. • **Control de la velocidad del habla:** uso de tableros de ritmo o marcado de sílabas para reducir la velocidad y mejorar la inteligibilidad en los casos donde el habla es demasiado rápida. • **Ejercicios de contraste prosódico:** repetición de una misma frase variando el énfasis en distintas palabras, para

	trabajar la prosodia y la inteligibilidad.
Articulatorias	• **Actividades de articulación con todas las consonantes en sílabas directas:** • **Ejercicios ortofónicos**: articulación de fonemas, utilización en sílaba directa con las diversas vocales para pasar, después, a las palabras, y, finalmente, a las frases. • **Actividades de articulación correcta de las sílabas inversas** (i.e., l, n, r, s). • **Actividades de articulación correcta de sílabas dobles o sinfones**. • Articulación del primer fonema en sílaba directa y del segundo fonema en sílaba indirecta. Unión de las dos sílabas en una palabra • **Actividades de forma fluida palabras y frases:** Construcción de frases mientras se observan fotografías o dibujos.
Propias del lenguaje oral	• Rimas, trabalenguas, adivinanzas. • Trabajo con campo semántico teniendo en cuenta el fonema alterado. • Uso de onomatopeyas mediante la combinación de sonidos fuertes y débiles. • Cambios de ritmo en los sonidos. • Ejercicios de lectura silenciosa y lectura en voz alta. • Descripción de láminas, narración de hechos en la vida diaria.

Fuente: elaboración propia

2.1.3. Disglosia

2.1.3.1. Conceptualización, características y desarrollo de la alteración

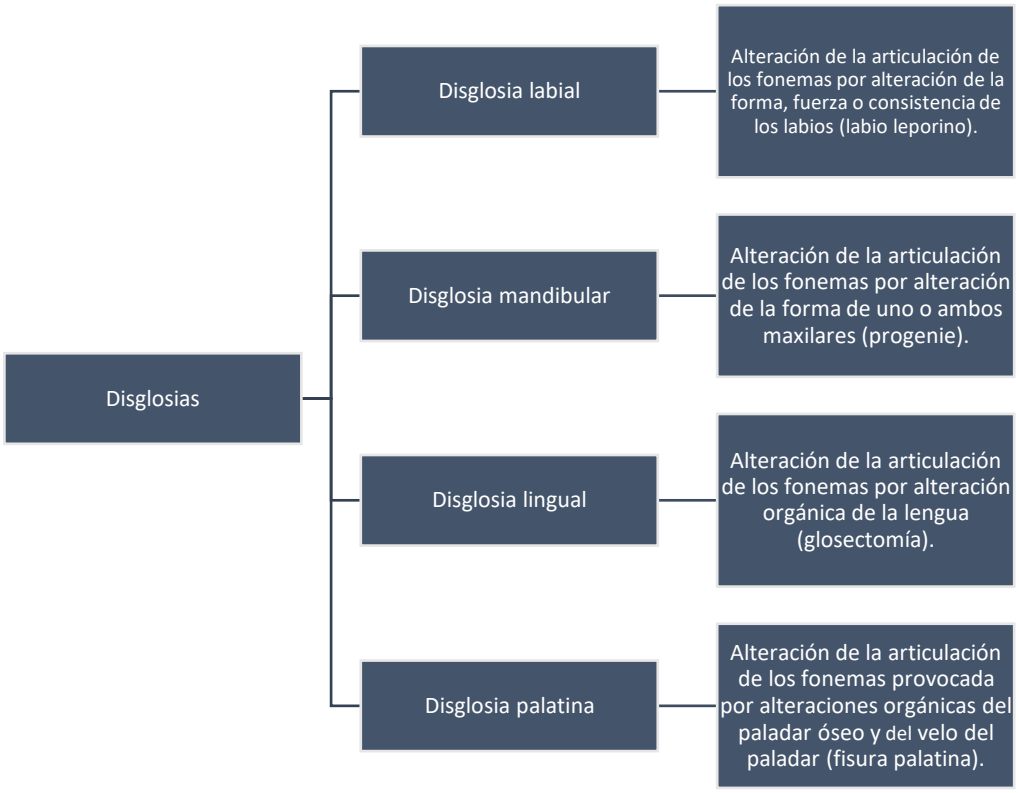
Se conocen como disglosias a las alteraciones de la articulación de los fonemas causados por trastornos de los órganos periféricos del habla y de origen no neurológico central. Estas pueden tener varias causas y se localizan en diferentes órganos del habla, únicas o asociadas. Pueden diferenciarse entre las malformaciones congénitas, las alteraciones del crecimiento, las parálisis periféricas, traumatismos y sus consecuencias (Coll-Florit et a., 2014).

2.1.3.2. Taxonomía diferencial

Según su división anatómica puede diferenciarse, principal entre: disglosias labiales, mandibulares, linguales y palatinas (véase Figura 3).

Figura 3.

Tipos de disglosia (Molina, 2017)



2.1.3.3. Evaluación

Siguiendo a Molina (2017), el principal criterio que se utiliza para diagnosticar la disglosia de un sujeto es la presencia de dificultades para articular fonemas debido a la malformación orgánica.

Sin embargo, para, posteriormente, llevar a cabo la intervención es preciso tanto identificar qué órgano u órganos periféricos del habla se encuentran afectados como atender a la intensidad o gravedad con la que se presente el tipo de disglosia. Para ayudar a lo anterior, existen numerosas pruebas de evaluación que permitirán obtener un diagnóstico fiable (véase Tabla 3).

Tabla 3.

Principales pruebas de evaluación para la disglosia (EOEPS)

Instrumento	Aspecto evaluado	Aplicación en la evaluación de la disglosia
Protocolo de Evaluación Miofuncional Orofacial (MBGR)	Morfología y funciones orofaciales (respiración, masticación, deglución, habla)	Permite valorar las alteraciones estructurales y funcionales del sistema estomatognático que pueden afectar al habla.

Instrumento	Aspecto evaluado	Aplicación en la evaluación de la disglosia
OMES-E (Orofacial Myofunctional Evaluation with Scores – Expanded)	Estructuras y funciones orofaciales	Evalúa labios, lengua, mandíbula, paladar, respiración, deglución y articulación mediante un sistema de puntuación estandarizado.
Protocolo de Exploración Miofuncional Orofacial (PEMO)	Exploración anatómica y funcional	Facilita la valoración clínica de las estructuras orofaciales y de las funciones estomatognáticas.
Exploración clínica orofacial	Labios, lengua, paladar, dentición, oclusión, frenillos y movilidad	Constituye la valoración inicial imprescindible para determinar la existencia de alteraciones anatómicas compatibles con una disglosia.
Protocolo LEA	Exploración del lenguaje oral, articulación y estructuras bucofonatorias	Permite valorar la producción de los fonemas, las características del habla y realizar una exploración funcional de los órganos bucofonatorios, siendo útil para identificar alteraciones compatibles con una disglosia y orientar la necesidad de una evaluación complementaria.

2.1.3.4. Intervención

La intervención comienza a los dos años con el logopeda, siendo a partir de los tres años y hasta los doce realizado por el Maestro/a de Audición y Lenguaje (González y García, 2019). En líneas generales la intervención del Maestro/a de Audición y Lenguaje suele ser continua a lo largo de la etapa infantil y primaria, variando la intensidad. Al principio, la intervención es intensiva, luego se van combinando periodos de descanso con periodos de intervención puntual para volver a trabajar y corregir articulación y habla en general (Neira y Gómez, 2012).

En lo que respecta a la intervención en la disglosia, esta debe ajustarse a la causa estructural, a las características del alumnado y a los fonemas afectados (Cepeda, 2019). Asimismo, debe desarrollarse de manera coordinada con los profesionales sanitarios implicados y orientarse a mejorar la producción funcional y la inteligibilidad del habla. Teniendo en cuenta lo anterior, se proponen los siguientes procedimientos:

- Coordinación con el equipo médico-quirúrgico: en los casos de disglosia de causa estructural (fisura palatina, labio leporino, malformaciones mandibulares), la intervención logopédica debe ir siempre coordinada con el otorrinolaringólogo, cirujano maxilofacial y/o protésico, ya que la corrección de la causa orgánica (cirugía,

prótesis, ortodoncia) es el primer paso necesario antes o durante la intervención en el habla.

- Intervención articulatoria directa sobre los fonemas afectados: identificación de los fonemas concretos que el niño no articula correctamente en función del órgano dañado (labial, lingual, mandibular o palatino) y práctica repetida de esos fonemas en sílabas, palabras y frases.
- Trabajo de la conciencia fonológica como apoyo a la articulación: segmentación de palabras, identificación de sonidos iniciales y finales, y discriminación auditiva de los fonemas que el niño confunde o sustituye.
- Feedback articulatorio con apoyo visual: uso de espejo, láminas o vídeos que muestren al niño el punto y modo de articulación correcto, para compensar visualmente la limitación física del órgano afectado.
- Generalización progresiva: una vez conseguida la articulación correcta en sílabas aisladas, se avanza a palabras, frases y habla espontánea".
- Reeducación muscular orofacial:
    - Masaje digital de rotación sobre la cicatriz, para suavizarla.
    - Masaje a lo largo del labio para darle elasticidad.
    - Masaje alrededor de los labios siguiendo su contorno para reducir la rigidez.
    - Tracciones en los labios.
    - Dar golpecitos muy rápidos con los dedos en los labios y también en las mejillas.
    - Masaje del labio superior en dirección vertical y horizontal.
- Reeducación muscular lingual para trabajar las praxias linguales:
    - Movimientos dentro y fuera de la boca, arriba y abajo o circulares.
    - Doblar-estirar.
    - Afinar-ensanchar.
    - Lamer.
    - Presionar
- Reeducación de los músculos buccinadores (se encuentran en las mejillas):
    - Abrir y cerrar la boca.
    - Enseñar incisivos superiores e inferiores.
    - Hinchar carrillos.
- Reeducación mandibular:
    - Movimiento de masticación exagerado.
    - Movimiento de mandíbula derecha-izquierda, delante-detrás.

- Reeducación velo-palatina:
    - Ejercicios de succión (i.e., trasvasar agua por medio de una pajita, aspirar papeles con una pajita (variando su grosor), aspirar agua sin tragarla, manteniéndola un tiempo en la pajita).

En línea con lo anterior, Rivera y Carchi (2021) añaden que se ha de mantener un contacto y comunicación abierta y sincera entre todos los profesionales, mayor al principio y más distendida conforme la intervención progrese y se sienten las bases de esta.

2.1.4. Disfonía

2.1.4.1. Conceptualización

Se considera que hay una alteración de la voz cuando su timbre, tono, intensidad o flexibilidad difieren de los de las voces de las demás personas del mismo género, edad y grupo cultural con desarrollo típico.

En este sentido, la disfonía es un cambio en el tono de la voz, percibido por el sujeto y su entorno, que se produce por una mala vibración de una o ambas cuerdas vocales (Castillo et al. 2015). Dicha alteración indica una patología laríngea y no debe confundirse con otras alteraciones de la voz que se producen por una modulación inadecuada de esta en el área orofaríngea (i.e., rinolalia, faringolalia o déficit fonatorio derivado por enfermedades que afectan a la capacidad pulmonar).

La disfonía puede ser debida a una gran heterogeneidad de causas. Actualmente, tal y como apuntan Cobeta et al. (2013) no existe una nomenclatura estándar para los procesos de producción de los trastornos de la voz ni para las subpatologías de las cuerdas vocales, pero, como ya se mencionó, estas se pueden dividir en orgánicas, funcionales, psicógenas y, también, en lesiones mínimas asociadas, todas ellas interrelacionadas mediante mecanismos de causa y efecto.

2.1.4.2. Taxonomía diferencial

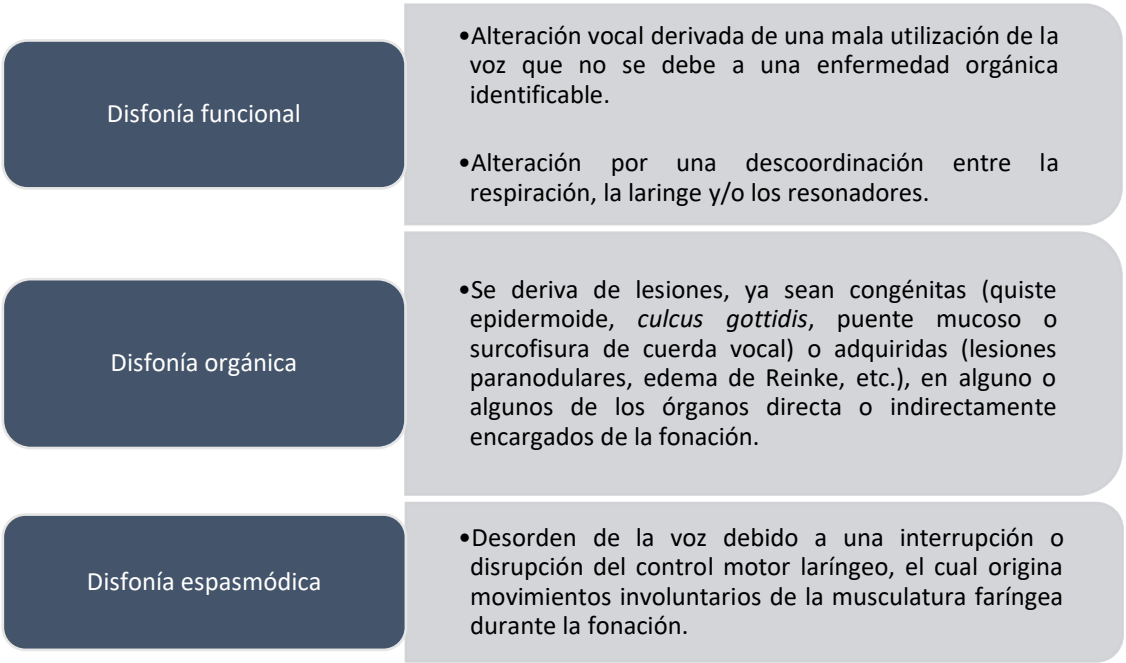
En la actualidad no existe una nomenclatura estándar para los trastornos de la voz ni para la patología de las cuerdas vocales. En el pasado, el término de disfonía funcional se identificaba con idiopático e incluía numerosos casos de disfonía en los que, probablemente, debido a las limitaciones de los procedimientos de exploración, no podía reconocerse ninguna alteración de la forma ni del comportamiento laríngeo (Sanz et al. 2015).

Además, tampoco estaba clara, tomando en consideración las diversas culturas y lenguas, la diferencia entre los términos funcional y psicógeno, lo cual generaba interpretaciones erróneas derivadas de la no individualización de ambas causas tan afines.

La definición de disfonía funcional considera que son funcionales todas las formas de alteración vocal en que la desviación del patrón normal de funcionamiento es el mayor factor causal y que, por ello, se encuentra ligada a la consideración de perturbación del gesto vocal (Saavedra-Mendoza y Akaki-Caballero, 2014).. Sobre esta premisa conceptual se precisa que los trastornos de la voz, o disfonías, pueden dividirse en funcionales, orgánicas o espasmódicas (véase Figura 4).

Figura 4.

Clasificación de las disfonías (Saavedra-Mendoza y Akaki-Caballero, 2014)



Estudios epidemiológicos recientes realizados en grandes poblaciones han demostrado que la prevalencia de los trastornos vocales se encuentra en torno al 1%, con mayor frecuencia de afectación del género femenino, siendo la edad más frecuente entre los 25 y 45 años. En la infancia, la disfonía es más frecuente en niños, pero, en la edad adulta, se diagnostican con frecuencia lesiones benignas de las cuerdas vocales, disminuyendo su incidencia conforme avanza la edad.

2.1.4.3. El particular caso de la disfonía infantil: introducción

En algunos niños, el trastorno de la voz es muy precoz y se intensifica con el tiempo. En otros aparece más tarde y comprende episodios breves y agudos con periodos de mejoría. Más tarde, aumentan las dificultades y la disfonía es cada vez más frecuente hasta llegar a ser permanente (Vila, 2009). El niño puede quejarse de quemazón, pinchazos, sequedad y sensación de cuerpo extraño en la garganta, entre otras molestias.

En un primer estadio, las cuerdas están rosadas; luego edematosas, hinchadas y recubiertas de secreciones. En el niño disfónico, sea cual su edad y la gravedad de su trastorno, todas las características acústicas están alteradas y modificadas (Gutiérrez, 1992). El timbre vocal está reemplazado por otro patológico que en las disfonías hiperfuncionales da la impresión de esfuerzo vocal.

Con frecuencia, las disfonías infantiles no son detectadas en el ámbito familiar. A veces, discretas alteraciones de la voz no alarman a los padres, sobre todo en entornos familiares donde la madre o el padre habla con gran intensidad o cuando uno de los dos presenta una voz disfónica. En estos ambientes es fácil que el niño acabe imitando el comportamiento vocal (Melo et al. 2001).

Por tanto, el modelo vocal que ofrecen los padres es importante, dado que el pequeño suele identificarse con el estilo comunicativo ya sea este tranquilo, nervioso, dialogante o agresivo. Por otra parte, cuando un niño sufre una ronquera no se le suele dar importancia, pues se piensa que no se trata de una enfermedad y que no tiene repercusiones sobre su salud actual o futura: se puede considerar que es un niño chillón, hablador o inmaduro.

En muchas ocasiones es en el colegio en donde se detectan problemas relacionados con la voz o el habla, por ello es importante que el medio escolar esté sensibilizado y preparado para detectar en sus inicios una alteración de la voz infantil y, de esta manera, orientar a los padres y poder realizar una tarea preventiva o dirigir hacia una intervención específica (Betances y Vallés, 2019).

Así, un factor que puede influir negativamente en la educación vocal es el ejemplo que supone el protagonismo del uso abusivo de la televisión: la expresión oral está en consonancia con los contenidos, valores y presentación que transmiten muchos programas y las voces que pueden adquirir características agresivas y timbres metálicos.

2.1.4.4. El particular caso de la disfonía infantil: evaluación e intervención

Hay una serie de signos subjetivos que ya se han reseñado y que, con frecuencia, ni el niño ni sus padres reconocen como problema; solo en algunos casos el niño está molesto y se queja de que su voz «sale con dificultad». A veces, los pequeños refieren picores, sensaciones urentes, tensiones, dolores u opresión respiratoria similares a los que describen los adultos (Fleta, 2021).

A menudo, el niño reconoce que está molesto cuando trata de hablar «no muy alto» y leer en clase, ya que la voz para gritar o para llamar no le plantea, según él, problema alguno. Por ello, de cara a una intervención de calidad, es importante tener en cuenta los principales signos objetivos (véase Tabla 4).

Tabla 4.

Principales signos objetivos de disfonía infantil (Fleta, 2021)

Signos objetivos	Descripción
La alteración de la voz conversacional es variable	Acústicamente se caracteriza por descenso en la tonalidad, reducción de la modulación, ronquera del timbre, a menudo muy acusada, finales fonatorios a veces sofocados y alteración de la articulación de la palabra debido al esfuerzo vocal. Estas manifestaciones acústicas tienen un evidente comportamiento de sobreesfuerzo: alteración del soplo fonatorio, alteración de la verticalidad e ingurgitación de la yugular.
En la prueba de lectura, la voz suele estar todavía más alterada que en la conversación.	En la prueba de la voz proyectada se aprecia una mejoría, a menudo bastante importante de la voz, que en algunos casos puede ser completamente clara, aunque siempre está el comportamiento vocal de sobreesfuerzo.
En la exploración de la pared abdominal, en el niño disfónico se observa una protrusión abdominal y en una proporción bastante elevada (70%).	En la estática corporal se ha descrito la existencia de problemas relacionados con la estática general corporal, que se manifiesta mediante caídas frecuentes.
La postura y la respiración tienen una gran importancia en la emisión de la voz.	Primero porque un cuerpo que no mantiene una buena verticalidad no puede producir una voz fisiológicamente correcta. En esta circunstancia, muy frecuente en niños con disfonía, la respiración tampoco se lleva a cabo de manera flexible ni puede dar sustento a la emisión de la voz. La postura es la respuesta del cuerpo a la acción de la gravedad. En el resultado de esta adaptación intervienen diversos factores de tipo mecánico, como cargar pesadas mochilas en la espalda o mantener posturas poco adecuadas a la hora de sentarse en clase, o factores de tipo médico y constitucionales. En los niños con trastornos de voz se observa una postura característica: la cabeza está adelantada deprimiendo la zona cervical y desplazando la parte anterior del cuello de modo que las cuerdas vocales quedan fuera de su eje vertical. La zona de las vértebras dorsales se presenta encorvada, provocando el hundimiento de la parte anterior del

	tórax, y las costillas se «hunden», impidiendo que el diafragma realice los movimientos propios de una buena respiración.
Signos laringoscópicos	Se observan lesiones más o menos importantes de la mucosa de los repliegues vocales y el edema de cuerdas que corresponden a laringopatías disfuncionales, es decir, consecutivas al comportamiento de sobreesfuerzo. De estos, los más frecuentes son los nódulos vocales y, con menos frecuencia, los quistes de retención mucoide y pseudoquistes. La exploración laringoscópica es la que permite diferenciar la disfonía funcional infantil de las disfonías de origen orgánico, como el sulcus, la glotis oval, el quiste congénito y los papilomas.

Con todo lo anterior, lo primero que se hará será llevar a cabo una recogida de información entrevistando a las personas que forman parte del entorno del niño o la niña, principalmente, la familia. No obstante, la entrevista puede ser realizada con el/la profesor/a, pues puede observar dificultades en sus estudiantes (Gómez y Álvarez, 2005).

La información que se suele demandar hace referencia a datos personales del niño/a, motivo de consulta, momento en que se observa la dificultad, datos sobre el desarrollo del niño/a (tanto lingüístico como motor), alimentación, datos familiares, etc. (Morante, 2001). En el caso de las disfonías infantiles se requiere una exploración otorrinolaringológica previa con el fin de observar el estado de la laringe (sobre todo, las cuerdas vocales).

En segundo lugar, tal y como señalan, Gómez y Álvarez (2005), se aborda el proceso de evaluación propiamente dicho con el fin de caracterizar las dificultades observadas y emitir un diagnóstico. Es imprescindible que la evaluación sea completa y describa el comportamiento vocal o el habla del niño/a con exactitud, puesto que los objetivos de la intervención (y, en general, todo el proceso de intervención) se fijarán en función de este proceso. En caso de sospechar que el niño o la niña presenta un TV (posible disfonía infantil) el/la especialista debe realizar una exploración funcional de la voz. En esta exploración, siguiendo a Sánchez et al. (2015) se llevan a cabo una serie de pasos:

- Observación del lenguaje espontáneo.
- Observación de la postura.
- Exploración de la tensión en cuello y cara.
- Medida de la capacidad y frecuencia respiratoria.

- Medida de la duración del soplo espiratorio sonoro del niño/a (se evalúa la duración en segundo del sonido.
- Exploración de la tos.
- Análisis de una muestra de habla proyectada en enumeración.
- Análisis de la lectura en voz alta.

Si el niño o la niña ha sido remitido/a al especialista en lenguaje por trastorno del habla (posible dislalia), tras la recogida de información se exploran las bases funcionales de la articulación y, más tarde, la articulación propiamente dicha (Sánchez et al. 2015). Por un lado, las bases funcionales de la articulación que se deben evaluar son:

- Órganos bucofonatorios (explorar la habilidad motora de labios, lengua, velo del paladar, mandíbula; observar estructura de estos y de los órganos pasivos, es decir, dientes, paladar duro y fosas nasales).
- Discriminación auditiva y respiración.

Por otro lado, una vez realizada la exploración de las bases funcionales se evalúa la articulación del niño/a con dificultades de habla (Sánchez et al. 2015). Los aspectos que se deben explorar en este proceso son:

- Lenguaje espontáneo mediante conversación libre.
- Lenguaje dirigido con y sin referencia visual.
- Lenguaje repetido.
- Lectura en voz alta.

Con todo, el/la especialista puede conocer el repertorio de fonemas (o sonidos de la lengua) del niño o niña y observar si existen procesos de sustitución, omisión, adición o distorsión de estos. Así pues, es habitual aplicar pruebas estandarizadas que permiten, además de registrar las peculiaridades del habla del niño o niña, comparar cuantitativamente su ejecución con la media de un grupo de su edad (Fleta, 2021).

Finalmente, cabe mencionar que, una de las pruebas estandarizadas más comunes es la denominada *Registro Fonológico Inducido- RFI* (Monfort y Juárez, 1989) para niños con edades comprendidas entre 3 y 7 años. Se trata de una prueba compuesta por 57 tarjetas con dibujos cuyas denominaciones cubren el espectro fonológico fundamental del español, es decir, aparecen todos los fonemas y en todas las posiciones posibles. La aplicación de la prueba es individual, con una duración aproximada entre 10 y 20 minutos, y se deben anotar las respuestas del niño/a en una hoja de protocolo.

BIBLIOGRAFÍA

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5.ª ed., texto revisado). Washington, DC: APA.

Betances, F., y Vallés, H. (2019). Prevalencia de disfonía infantil en el Colegio de Educación Infantil y Primaria "Ensanche" de Teruel. *Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, 79*(2), 159-166.

Castillo, A., Casanova, C., Valenzuela, D., y Castañón, S. (2015). Prevalencia de disfonía en profesores de colegios de la comuna de Santiago y factores de riesgo asociados. *Ciencia y trabajo, 17*(52), 15-21.

Cepeda, A. (2019). Trastornos de la comunicación y lenguaje II: Intervención. EOPEP´S: Junta de Castilla y León. Disponible en: https://www.educa.jcyl.es/crol/es/recursos-educativos/trastornos-comunicacion-lenguaje-ii-intervencion

Cobeta, I., Núñez, F., y Fernández, S. (2013). *Patología de la voz*. Marge books.

Cobeta, I., Núñez, F., y Fernández, S. (2013). Voz normal y clasificación de las disfonías. *Revista de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial, 8*, 237-241.

Coll-Florit, M., Vila-Rovira, J. M., Aguado, G., Fernández-Zúñiga, A., Gambra, S., y Perelló, E. (2014). *Trastornos del habla y de la voz*. Barcelona: UOC.

Fleta, J. (2021). Disfonía en la infancia. Valoración y pauta para seguir. *Boletín de la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria, 51*(2), 81-85.

Gómez, S. L., y Álvarez, C. G. (2005). La prevención de dificultades del lenguaje oral en el marco escolar: Evaluación e intervención temprana. *Pensamiento Psicológico, 1*(5), 73-83.

González, J.J., y García, J.M. (2019). Trastornos del lenguaje y la comunicación. *Congreso de Actualización Pediatría*, *3*, 569-577.

Hernández, N. M. (2007). Intervención logopédica en la disartria. *Revista de logopedia, foniatría y audiología, 27*(4), 187-197.

Melle, N. (2007). Guía de intervención logopédica en la disartria. Madrid: Síntesis.

Melle, N. (2012). Disartria. Práctica basada en la evidencia y guías de práctica clínica. *Revista de logopedia, foniatría y audiología, 32*(3), 120-133.

Melo, E. C. M. D., Mattioli, F. M., Brasil, O. C., Behlau, M., Pitaluga, A. C., y Melo, D. M. D. (2001). Disfonia infantil: aspectos epidemiológicos. *Revista brasileira de otorrinolaringologia*, *67*, 804-807.

Molina, F. P. (2017). Disglosia labial y palatal en Educación Primaria. Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad, 3(1), 94-107.

Monfort, M., y Juárez, A (1998). *Registro Fonológico Inducido*. Madrid. Editorial. CEPE.

Morante, M. (2001). La voz: recurso para la educación, rehabilitación y terapia en el ser humano. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado*, *42*, 67-75.

Neira, A. L., y Gómez, M. E. (2012). La disglosia y su influencia en la comunicación verbal de los niños (Tesis Doctoral. Universidad de Guayaquil).

Ortiz, K. (2014). Tratado de evaluación de motricidad orofacial y áreas afines. Madrid: EOS.

Peña, J. (1995). Rehabilitación de las afasias y trastornos asociados. Barcelona: Masson.

Rivera, B. R., y Carchi, P. A. (2021). Programa de intervención logopédica para corregir y/o compensar el retraso de lenguaje de un alumno con discapacidad intelectual (Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Educación del Ecuador).

Saavedra-Mendoza, A. G. M., y Akaki-Caballero, M. (2014). Guía de práctica clínica de disfonía basada en evidencia. *Anales de Otorrinolaringología Mexicana, 59*(3), 195-208.

Sánchez, P., Belda, A., y Shen, M. (2015). Detección temprana de los trastornos de la voz y del habla en el aula. Educación inclusiva: realidad y desafíos, *2,* 245-253.

Sanz, L., Rodríguez, M., Bau, P., y Rivera, T. (2015). Disfonía. *Medicine-Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 11*(91), 5433-5444.

Susanibar, F., Dioses, A., Marchesan, I., Guzmán, M., Leal, G., Guitar, B., y Junqueira, A. (2016). *Trastornos del habla: de los fundamentos a la evaluación*. Madrid: Giunti EOS.

Vila, J. M. (2009). Guía de intervención logopédica en la disfonía infantil. Madrid: Síntesis, 2009.